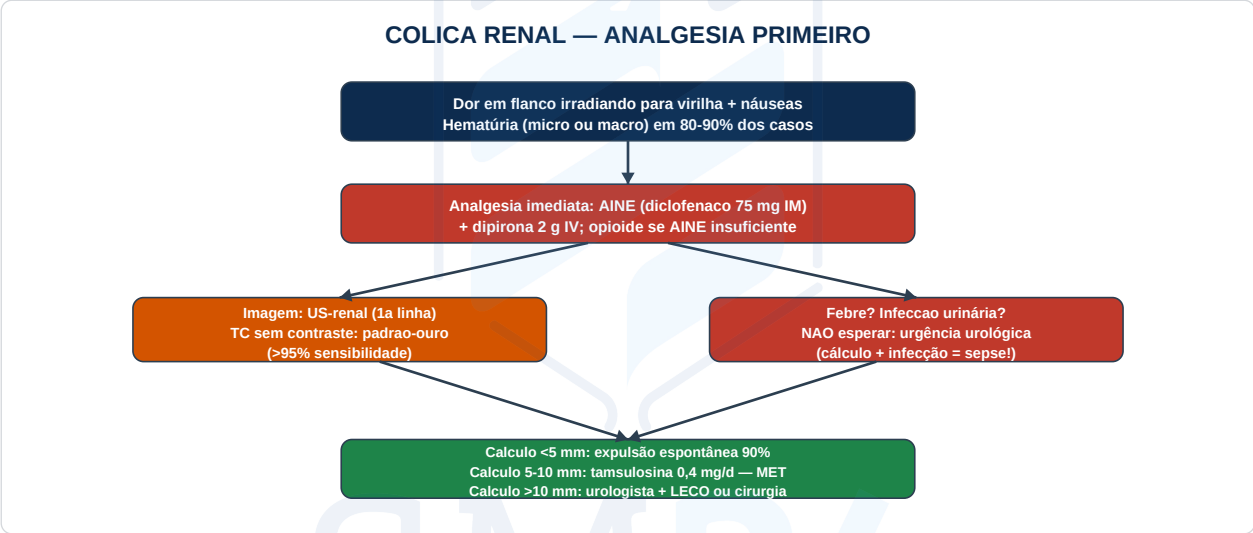


COLICA RENAL — ANALGESIA + IMAGEM + CONDUTA

CLASSIFICAÇÃO DO CÁLCULO — TIPOS E TRATAMENTO

Tipo de Cálculo	Frequência	Associado a	Tratamento específico
Oxalato de cálcio	70-80%	Hipercaleiúria, hiperoxalúria, baixa hidratação	Tiazídico, citrato de K+, hidratação
Fosfato de cálcio	5-10%	Hipercaleiúria, hiperparatireoidismo	Tratar causa, citrato de K+
Ácido úrico	5-10%	Hiperuricemia, gota, urina ácida (pH <6)	Alopurinol, alcalinizar urina (pH 6-7), hidratação
Estruvita (infecção)	5-15%	Proteus, Klebsiella (urease+) — persistente	ATB + litotripsia/cirurgia (cálculo de coral)
Cistina	1-2%	Cistinúria genética — autosom. recessiva	Hidratação intensa, D-penicilamina, alcalinização

MANEJO DA COLICA RENAL AGUDA



INDICACOES CIRÚRGICAS DE URGÊNCIA

Indicação	Conduta
Cálculo + infecção (febre + cálculo obstrutivo)	Drenagem URGENTE: nefrostomia ou ureteroscopia + ATB IV
Dor refratária a opioides IV por >2h	Urologista — pode necessitar drenagem
Cálculo em rim único ou transplantado	Urgência urológica — risco de anúria
Anúria bilateral (cálculos bilaterais)	Drenagem bilateral urgente — nefrostomia
Cálculo >10 mm sem passagem espontânea	Litotripsia extracorpórea (LECO) ou ureteroscopia eletiva
Hematuria maciça com coágulos	Cateterismo contínuo + hemostasia urológica

EXAMES E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Exames na Cólica Renal

- EAS + urocultura: hematúria (80-90%), leucocitúria (infecção), cilindros
- Ureia e creatinina: avaliar função renal (obstrução bilateral ou rim único)
- Hemograma: leucocitose — infecção associada
- US renal-vesical: 1a linha — identifica hidronefrose e cálculos >3 mm
- TC sem contraste: padrão-ouro — sensibilidade 96%, especificidade 98%; todos os tipos de cálculo
- RUB (rx urinário): apenas cálculo radio-opaco (oxalato/fosfato); ácido úrico é radioluciente

Diagnóstico Diferencial

- Pielonefrite aguda: febre, disúria, ângulo costovertebral sensível; cultura +
- Apendicite: dor migra para FID, sem hematúria, Blumberg positivo
- Gravidez ectópica: beta-hCG positivo; dor pélvica, sem dor em flanco
- Colecistite: dor em hipocôndrio direito, sem hematúria, murphy positivo
- Aneurisma de aorta abdominal: >50 anos, massa pulsátil, hematúria pode ocorrer
- Torção testicular: dor irradiada para escroto, testículo elevado

TERAPIA EXPULSIVA MÉDICA (MET) — TAMSULOSINA

Aspecto	Detalhe
Mecanismo	Alfabloquador seletivo (alfa-1d) — relaxa musculatura lisa ureteral, facilita expulsão
Indicação	Cálculo ureteral 5-10 mm assintomático ou com dor controlada
Dose	Tamsulosina 0,4 mg/d VO até expulsão ou 4 semanas
Eficácia	Reduz tempo de expulsão em 3-5 dias; aumenta taxa de expulsão em 20%
Efeitos adversos	Hipotensão ortostática (tomar deitado); ejaculação retrógrada
Observação	Cálculo <5 mm: expulsão espontânea >90% — MET pode ser oferecida mas não obrigatória

ALTA SEGURA DA CÓLICA RENAL

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

- ☐ Dor controlada com AINE oral ou opioide fraco
- ☐ Sem febre (T <37,8°C) — se febre: internar e drenar
- ☐ Sem anúria / sem rim único obstruído
- ☐ Cálculo <10 mm com chance de expulsão espontânea
- ☐ Orientar: hidratação 2-3 L/d, tamsulosina 0,4 mg/d, peneirar urina para análise
- ☐ Retorno em <48h se: febre, anúria, dor intensa refratária, vômitos incoercíveis

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 38 anos com dor em flanco direito irradiando para virilha, hematúria. Qual é o exame de imagem padrão-ouro?

- A) RUB (radiografia de rins, ureteres e bexiga)
- B) US renal
- C) TC de abdome e pelve SEM contraste
- D) RM urológica
- E) Urografia excretora

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com cólica renal e febre 38,5°C. TC confirma cálculo ureteral obstrutivo. Qual é a conduta?

- A) Alta com AINE e tamsulosina — febre comum na cólica
- B) Internação + ATB IV + drenagem urgente (nefrostomia ou JJ double-pigtail)
- C) Litotripsia extracorpórea de emergência
- D) Observação por 24h com analgesia e reavaliação
- E) Aumentar dose de AINE e aguardar expulsão espontânea

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Cálculo de ácido úrico é diferente dos de oxalato porque:

- A) É o mais comum (>70% dos casos)
- B) Aparece claramente em todos os exames de imagem
- C) É RADIOLUCENTE (invisível no RUB) — visível apenas na TC ou US
- D) Causa hipercalcúria e hiperparatireoidismo
- E) Não pode ser tratado clinicamente

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Qual tipo de cálculo urinário está associado a infecções por bactérias produtoras de urease (Proteus, Klebsiella)?

- A) Oxalato de cálcio
- B) Ácido úrico
- C) Estruvita (fosfato de amônio magnésico) — cálculo de coral
- D) Cistina
- E) Fosfato de cálcio

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que o AINE (diclofenaco, cetoprofeno) é preferido ao opioide como primeira linha na cólica renal?

- A) Porque é mais barato e de administração mais fácil
- B) Porque o AINE reduz a produção de prostaglandinas renais, diminuindo a pressão ureteral e o espasmo — além de analgesia comparável ao opioide
- C) Porque opioides causam dependência e são contraindicados na urgência
- D) Porque o AINE é mais eficaz em todos os tipos de dor
- E) Porque o AINE protege o rim contra a lesão por obstrução

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

TC sem contraste: padrão-ouro para litíase urinária — sensibilidade 96-98%, especificidade 98%. Detecta todos os tipos de cálculo (inclusive ácido úrico, invisível no RUB). RUB: apenas radio-opacos. US: boa para hidronefrose, mas pode perder cálculos uretrais distais.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Cálculo + febre = obstrução urinária + infecção = pionefrose potencial. URGÊNCIA UROLÓGICA: risco de sepse e perda do rim. Internação + ATB IV (ceftriaxona ou piperacilina-tazobactam) + drenagem urgente (nephrostomia percutânea ou cateter JJ). Não aguardar — mortalidade alta sem drenagem.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Cálculo de ácido úrico: radioluciente — formado em urina ácida (pH <6), sem cálcio. Invisível no RUB mas visível na TC (hipoatenuante) e US. Tratamento diferenciado: alcalinizar urina (pH 6-7 com citrato de K⁺ ou bicarbonato) e alopurinol — possível dissolução sem cirurgia.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Estruvita (fosfato de amônio magnesiano): bactérias urease-positivas (Proteus, Klebsiella, Pseudomonas) hidrolisam ureia → amônia → alcaliniza urina → precipita estruvita + apatita. Forma cálculos de coral (preenche a pelve renal). Tratamento: ATB + litotripsia ou cirurgia (não dissolve com alcalinização).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

AINE na cólica: inibe prostaglandinas renais (PGE2) → reduz TFG ipsilateral → diminui produção urinária → reduz pressão ureteral proximal → alívio da cólica. Analgesia equivalente ou superior ao opioide IV para cólica ureteral (metanálises). Contraindicação: IRC, hipovolemia, uso de IECA.

SM24
Suporte ao Plantão Médico